# Bitácora Médica de Guardia

Periodo: 14/11/2026 | Hospitalización, Periféricos y Emergencia

AUTHOR
MD. ZAMBRANO PG MEDICINA INTERNA, MD. BUENDIA MRA MED INTERNA

PUBLISHED
November 14, 2026

## Resumen Ejecutivo de la Guardia

> ⓘ **Censo Operativo:** Total: **57** pacientes | Hospitalizados: **19** | Periféricos: **15** | Emergencia/Obs: **23** | Nuevos ingresos de guardia: **0**

**Accesos Rápidos:** Censo drive

## Checklist de la Visita Nocturna (Pendientes Críticos)

> [!IMPORTANT] Esta lista compila todas las tareas con horario crítico, exámenes STAT, controles de madrugada y cambios farmacológicos programados para el equipo de guardia.

| Prioridad | Cama | Paciente | Tarea / Pendiente | Horario / Ventana | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| URGENTE | **10A** | MOSQUERA SALVADOR PATRICIA ALEXANDRA C (HC 1334681) | UROTAC SIMPLE | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **10A** | MOSQUERA SALVADOR PATRICIA ALEXANDRA C (HC 1334681) | L: HOY BH UREA CREATININA ELECTROLITOS CALCIO IONICO (CONTEO MANUAL DE | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| STAT | **10A** | MOSQUERA SALVADOR PATRICIA ALEXANDRA C (HC 1334681) | EKG STAT | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |

| Prioridad | Cama | Paciente | Tarea / Pendiente | Horario / Ventana | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| URGENTE | **10B** | REYES SANCHEZ INES MAGDALENA C (HC 8140) | E: RMN DE ENCEFALO AGENDAR HOY EN LA MAÑANA | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| STAT | **10B** | REYES SANCHEZ INES MAGDALENA C (HC 8140) | EKG CADA DIA (STAT) | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **10B** | REYES SANCHEZ INES MAGDALENA C (HC 8140) | L: HOY BH UREA CREATININA ELECTROITOS CALCIO IONICO MAGNESIO DIMERO D | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **10D** | OÑA TELLO JOSELYN CAROLINA (HC 1719421) | PENDIENTE INFORME ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS DE CABEZ Y TORAX POSTERIOR | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **10D** | OÑA TELLO JOSELYN CAROLINA (HC 1719421) | PENDIENTE TOMOGRAFIA SIMPLE DE CABEZA, TORAX Y PELVIS | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **10D** | OÑA TELLO JOSELYN CAROLINA (HC 1719421) | VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO POR EL COMITÉ DE BIOÉTICA | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **11A** | YELA DÍAS NELSON ARNULFO (HC 641333) | E: PD INFORME DE TAC DE TORAX | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| STAT | **11A** | YELA DÍAS NELSON ARNULFO (HC 641333) | GSA STAT | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |

| Prioridad | Cama | Paciente | Tarea / Pendiente | Horario / Ventana | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| URGENTE | **11A** | YELA DÍAS NELSON ARNULFO (HC 641333) | L: HOY BH UREA CREATININA ELECTROLITOS PCR PERFIL LIPIDICO HBA1C TSH | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **11A** | YELA DÍAS NELSON ARNULFO (HC 641333) | LABORATORIOS (17H00): DESTACA MEJORIA DE AZOADOS POST-DIÁLISIS (UREA 67.8, CR | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **12A** | NICOLALDE CENTENO CESAR ENRIQUE (HC 554153) | PD REALIZACION ECO DOPPLER PORTAL | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| STAT | **3B** | BORJA PAUCARIMA VICTORIA AVELINA 69 AÑOS (HC N/D) | C: IC A CLINICA DEL DOLOR YA REALIZADA POR DOLOR CRÓNICO DEBIDO A LESIONES CERVICALES | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **6A** | RODRIGUEZ MORENO SEGUNDO EZEQUIEL (HC 2013397) | PENDIENTE EXÁMENES GENERADOS EL 12/11/2026 | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **6A** | RODRIGUEZ MORENO SEGUNDO EZEQUIEL (HC 2013397) | PENDIENTE TAC SIMPLE DE TÓRAX | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **6A** | RODRIGUEZ MORENO SEGUNDO EZEQUIEL (HC 2013397) | VALORACIÓN POR NEUMOLOGÍA | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |

| Prioridad | Cama | Paciente | Tarea / Pendiente | Horario / Ventana | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL | 6A | RODRIGUEZ MORENO SEGUNDO EZEQUIEL (HC 2013397) | PROXIMO CONTROL: 06/11/2026 | NOCTURNA_20_24 | ☐ Pendiente |
| URGENTE | 6C | ALMEIDA JARAMILLO JUAN CARLOS C (HC 2086486) | TAC SIMPLE DE CRÁNEO PENDIENTE | NOCTURNA_20_24 | ☐ Pendiente |
| URGENTE | 6C | ALMEIDA JARAMILLO JUAN CARLOS C (HC 2086486) | PENDIENTE REALIZACIÓN | NOCTURNA_20_24 | ☐ Pendiente |
| URGENTE | 6C | ALMEIDA JARAMILLO JUAN CARLOS C (HC 2086486) | PAAF DE GANGLIO CERVICAL (IMAGEN) PENDIENTE REALIZACIÓN | NOCTURNA_20_24 | ☐ Pendiente |
| URGENTE | 6D | FARINANGO ANDRADE JUAN MANUEL (HC N/D) | E: PENDIENTE RX DE TÓRAX ANTEROPOSTERIOR Y LATERAL | NOCTURNA_20_24 | ☐ Pendiente |
| URGENTE | 6 B | CABEZAS ALMEIDA VICTOR MANUEL (HC 2067347) | PLACA ED PELVIS PENDIENTE REVISAR | NOCTURNA_20_24 | ☐ Pendiente |
| URGENTE | 9B | CARRERA AGUIRRE MARTHA GRACIELA C (HC 2045964) | L. PENDIENTE RESULTADOS DE ELECTROLITOS 12/11/2026 | NOCTURNA_20_24 | ☐ Pendiente |

| Prioridad | Cama | Paciente | Tarea / Pendiente | Horario / Ventana | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| URGENTE | **9D** | GUERRERO PAULA DOLORES NARCIZA (HC 677814) | PD RESULTADOS DE TAC DE TORAX | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **AB1** | C (HC 599900) | EMO INFECCIOSO UROCULTIVO PENDIENTE RESULTADO | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| CONTROL | **ABREVIADOS 3** | GUEVARA JARAMILLO MARTHA YOLANDA C (HC 140019) | EXÁMENES DE CONTROL EL DIA LUNES | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **ABREVIADOS 3_2** | YAGUAPAZ HERNANDEZ HILDA GUADALUPE C (HC 1998461) | BIOMETRÍA, PCR, UREA, CREATININA, ELECTROLITOS, CALCIO IÓNICO, FÓSFORO, MAGNESIO, PROTEÍNAS TOTALES Y ALBÚMINA, HOY AM | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| CONTROL | **ABRV 2** | CALVA SALAS GRETA (HC 1158688) | EXAMENES DE CONTROL PARA EL DIA LUNES | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **ABRV 3A** | VARGAS BAUTISTA ANA PIEDAD C (HC 1234469) | HEMOCULTIVOS X 2 HOY | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **ABRV 3A** | VARGAS BAUTISTA ANA PIEDAD C (HC 1234469) | VALORACION POR HEMAOTLOGIA E INFECTOLOGIA | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **ABRV 3A** | VARGAS BAUTISTA ANA PIEDAD | TAC SIMPLE DE ALBOMEN Y PELVIS PENDIENTE | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |

| Prioridad | Cama | Paciente | Tarea / Pendiente | Horario / Ventana | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | C (HC 1234469) | | | |
| URGENTE | **ABRV 3A** | VARGAS BAUTISTA ANA PIEDAD C (HC 1234469) | PET SCAN HOY | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **ABRV 3B** | GAVIN YERBABUENA MARIA CRISTINA C (HC 1597943) | PD INFORME DE TAC DE ABDOMEN | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| CONTROL | **ABRV 3B** | GAVIN YERBABUENA MARIA CRISTINA C (HC 1597943) | LUNES EXAMENES DE CONTROL | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **ABRV 3B** | GAVIN YERBABUENA MARIA CRISTINA C (HC 1597943) | CLOSTRIDIIUM TOXINA A Y B HOY | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| CONTROL | **ABR 3A** | DUQUE VERGARA MARIA ESTHER (HC 109881) | CONTROL DE ELECTROLITOS A LAS 4 HORAS, LUEGO DE HABER RECIBIDO EL PRIMER CICLO DE NEBULIZACION | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **ABV1** | VASCONEZ RUALES CARLOS AUGUSTO (HC 297135) | BODY TAC SIMPLE | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| STAT | **ABV1** | VASCONEZ RUALES CARLOS | ELECTROCARDIOGRAMA STAT | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |

| Prioridad | Cama | Paciente | Tarea / Pendiente | Horario / Ventana | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | AUGUSTO (HC 297135) | | | |
| URGENTE | **ABV1** | VASCONEZ RUALES CARLOS AUGUSTO (HC 297135) | ECOGRAFIA DE TIROIDES AGENDADA, PENDIENTE REALIZAR | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| CONTROL | **ABV1** | VASCONEZ RUALES CARLOS AUGUSTO (HC 297135) | L: -MAÑANA BH PCT , PCR , GLUCOSA, ELECTROLTIOS | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| STAT | **ABV2** | MALDONADO CAYAMBE DARWIN BENITO C (HC 2090778) | ECOGRAFIA VESCICO PROSTATICA | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| CONTROL | **ABV2** | MALDONADO CAYAMBE DARWIN BENITO C (HC 2090778) | MAÑANA AM: PSA TOTAL Y LIBRE, CEA, AFP | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| STAT | **ABV 2** | FLORES NARANJO MENTOR GUILLERMO (HC 2062807) | EKG STAT | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **ABV 2** | FLORES NARANJO MENTOR GUILLERMO (HC 2062807) | UROTAC SIMPLE | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |

| Prioridad | Cama | Paciente | Tarea / Pendiente | Horario / Ventana | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL | ABV 2 | FLORES NARANJO MENTOR GUILLERMO (HC 2062807) | MAÑANA BIOMETRIA HEMATICA, ELECTROLITOS, UREA, CREATININA | NOCTURNA_20_24 | ☐ Pendiente |
| CONTROL | ABV 3 A | CAMACHO PINEDA RICAURTE DE JESUS C (HC 2087368) | LUNES EXAMENES DE LABORATORIO DE CONTROL | NOCTURNA_20_24 | ☐ Pendiente |
| URGENTE | AB 1_2 | GALLEGOS ACOSTA FERNANDA BETSABE C (HC 1727494) | ECOGRAFÍA DE ABDOMEN (HEPATITIS AUTOINMUNE) | NOCTURNA_20_24 | ☐ Pendiente |
| URGENTE | AB 2 | ALMAGRO PICO JORGE WASHINGTON 74 AÑOS (HC N/D) | HEMOCULTIVOS X2 DEL 04/11/2026 PENDIENTE RESULTADO | NOCTURNA_20_24 | ☐ Pendiente |
| URGENTE | CARDIO 3C | HIDALGO NIETO CARLOS GONZALO 72 AÑOS (HC 963279) | TAC SIMPLE DE ENCÉFALO, CUELLO, TÓRAX, ABDOMEN Y PELVIS. (HACER INFORMAR) | NOCTURNA_20_24 | ☐ Pendiente |
| URGENTE | CARDIO 3C | HIDALGO NIETO CARLOS GONZALO 72 AÑOS (HC 963279) | EDA Y COLONOSCOPIA REALIZADA: REPETIR COLONOSCOPIA PENDIENTE TURNO | NOCTURNA_20_24 | ☐ Pendiente |
| URGENTE | CARDIO 3C | HIDALGO NIETO CARLOS GONZALO 72 | VALORACIÓN POR CIRUGÍA VASCULAR (INSUFICIENCIA ARTERIAL CRONICA): ALTA | NOCTURNA_20_24 | ☐ Pendiente |

| Prioridad | Cama | Paciente | Tarea / Pendiente | Horario / Ventana | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | AÑOS (HC 963279) | | | |
| URGENTE | **CARDIO 4B** | 0200150688 GALEAS LOPEZ ROSA ELVIRA H.C.: 1814762 (HC 1814762) | E: TAC SIMPLE DE ENCEFALO, CUELLO, TORAX, ABDOMEN Y PELVIS PENDIENTE INFORME | NOCTURNA_20_24 | ☐ Pendiente |
| CONTROL | **CARDIO 4B** | 0200150688 GALEAS LOPEZ ROSA ELVIRA H.C.: 1814762 (HC 1814762) | L: CONTROL DIARIO DE ELECTROLITOS | NOCTURNA_20_24 | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **EMER_4** | CHIPANTAXI GUAÑA MARIANA (HC 521857) | INTERCONSULTA NEUMOLOGIA PARA TRAMITE DE OXIGENO | NOCTURNA_20_24 | ☐ Pendiente |
| STAT | **EMER_4** | CHIPANTAXI GUAÑA MARIANA (HC 521857) | BAJAR A AVERIGUAR FECHA DE BIOPSIA, YA ENTREGADO EL TRAMITE, AUN NO APROBADO POR RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA | NOCTURNA_20_24 | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **ER- AB 1** | PACIENTE: SANCHEZ LOPEZ EDDY ENRIQUE (HC N/D) | TAC SIMPLE DE ABDOMEN EN ESTE MOMENTO | NOCTURNA_20_24 | ☐ Pendiente |
| CONTROL | **HOSP_18** | ORTIZ MARIA ANGELA C (HC 520780) | LUNES EXAMENES DE LABORATORIO DE CONTROL | NOCTURNA_20_24 | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **INFECTOL** | LOPEZ FIGUEROA OLGA | PENDIENTE ECO DE HIGADO A DESCARTAR CIRROSIS | NOCTURNA_20_24 | ☐ Pendiente |

| Prioridad | Cama | Paciente | Tarea / Pendiente | Horario / Ventana | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MARLENE C (HC 1556289) | | | |
| STAT | **INFECTOLOGIA 4D** | GUERRON CASARES VICTOR MISAEL C (HC 165405) | REPETIR ELECTROLITOS STAT + UREA, CREATININA | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| STAT | **INFECTOLOGIA 4 C** | ARAUJO FIALLOS FAUSTO RAMIRO (HC N/D) | HEMOCULTIVO X 2 STAT | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| CONTROL | **INFECTO 1B** | ANDRANGO SIMBAÑA GONZALO (HC 307712) | CONTROL DIARIO DE ELECTROLITOS | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **INFECTO 1B** | ANDRANGO SIMBAÑA GONZALO (HC 307712) | REVALORACION POR INFECTOLOGÍA | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| STAT | **INTERMEDIOS** | GOMEZ ESPINOZA JUSTO ANGEL . (HC N/D) | ELECTROLITOS STAT | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| CONTROL | **INTERMEDIOS** | GOMEZ ESPINOZA JUSTO ANGEL . (HC N/D) | MAÑANA AM: ELECTROLITOS, UREA, CREATININA | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| STAT | **INTERMEDIOS** | GOMEZ ESPINOZA JUSTO ANGEL . (HC N/D) | HEMOCULTIVOS PENDIENTE RESULTADOS, /VERIFICAR SE HAYA ENVIADO MUESTRA | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **INTERMEDIOS** | GOMEZ ESPINOZA | REINTERCONSULTAR A TRAUMATOLOGÍA CON | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |

| Prioridad | Cama | Paciente | Tarea / Pendiente | Horario / Ventana | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | JUSTO ANGEL . (HC N/D) | RESULTADOS DE RESONANCIA DE CODO | | |
| URGENTE | **NEUMOLOGIA 10C** | C (HC 625308) | PENDIENTE INFORME DE TC S/C DE TÓRAX ABDOMEN Y PELVIS | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| CONTROL | **NEUMOLOGÍA 8B** | RODRIGUEZ QUIÑONEZ FRANKLIN (HC 2087745) | CONTROL DIARIO DE ELECTROLITOS, BIOMETRÍA Y TIEMPOS DE COAGULACIÓN | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **PERI_15** | UBILLUS ARGUERO MARIA TERESA (HC 2090357) | UROTAC SIMPLE. HACER INFORMAR | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| STAT | **PERI_15** | UBILLUS ARGUERO MARIA TERESA (HC 2090357) | NA, POTASIO, CL, MAGNESIO, PCT, EMO, UROCULTIVO, GRAM STAT | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **TRASNPLANTE RENAL 8B** | NOLIVOS CALDERON SILVIA ALEXANDRA C (HC 642799) | ELECTROMIOGRAFÍA PENDIENTE FECHA | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **UROLOGIA_2** | LIDIOMA MINANGO KATHERINE ELIZABETH C (HC 1786985) | PD TAC DE TORAX | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |
| URGENTE | **UROLOGIA_2** | LIDIOMA MINANGO KATHERINE ELIZABETH C (HC 1786985) | ECOCARDIOGRAMA PD TURNO | `NOCTURNA_20_24` | ☐ Pendiente |

# Mapa Microbiológico y Aislamientos de Alerta

| Cama | Paciente | Muestra | Microorganismo | Patrón / Resistencia | Terapia Sugerida / Sensible |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | No se registran cultivos activos | - | - |

# Detalle Clínico por Áreas y Camas

Hospitalización (19 pacientes) Periféricos (15 pacientes)

Emergencia / Observación (23 pacientes)

## Cama 10A: MOSQUERA SALVADOR PATRICIA ALEXANDRA C

- **HC:** `1334681` | **Cédula:** 1706511530 | **Edad:** 63 años | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** LITIASIS RENAL, YA HAN REALIZADO LITOTRICIA; COLELITIASIS DESDE ENERO 2026; OSTEOPOROSIS; PROLAPSO VESICAL DESDE HACE 4 MESES; INFECCION DE VIAS URINARIAS A REPETICIÓN

**Diagnósticos Activos:**

- SEPSIS A DOBLE FOCO URINARIO E INTESTINAL
- DC INFECCIÓN POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE
- LESIÓN RENAL AGUDA KDIGO III CKD EPI: 14 ML/MIN
- TROMBOCITOPENIA POR SEPSIS
- HIPONATREMIA HIPOOSMOLAR HIPOVOLEMICA /HIPOKALEMIA. /ACIDEMIA METABÓLICA
- FALLO MULTIORGANICO RENAL, HEPÁTICO, COAGULACIÓN. APACHE 13 PUNTOS

**Medicación Activa:**

- MEROPENEM 1 GRAMO IV CADA 8 HORAS (7) FI:05/11/2026 CIE: N390
- PARACETAMOL 1 GRAMO IV PRN
- OMEPRAZOL 20MG VO QD
- FUROSEMIDA 40MG IV 08H00 Y 20MG IV 18H00

**Pendientes:**

- ☐ URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** UROTAC SIMPLE
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** RMN DE COLUMNA LUMBAR
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** ELECTROFORESIS DE PROTEINAS (TRAMITE DERIVACION)

- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** PD RESULTADOS DE HEMOCULTIVOS
- [ ] URGENTE **[LABORATORIO]** L: HOY BH UREA CREATININA ELECTROLITOS CALCIO IONICO (CONTEO MANUAL DE
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** PLAQUETAS,) DIMERO D,PERFIL LIPIDICO,PERFIL HEPATICO, LIPASA
- [ ] STAT **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** EKG STAT
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** GSA PRN
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** ELECTROLITOS (GSA 16H26): K: 3.3 (DESCENSO EN RELACIÓN AL SÉRICO MATUTINO DE
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** 3.99), NA: 136, CL: 107
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** HEMOCULTIVOS NEGATIVOS

**Últimos Laboratorios:**

- *2026-11-14 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: - LITIASIS RENAL, YA HAN REALIZADO LITOTRICIA - COLELITIASIS DESDE ENERO 2026 - OSTEOPOROSIS - PROLAPSO VESICAL DESDE HACE 4 MESES - INFECCION DE VIAS URINARIAS A REPETICIÓN

**Observaciones / Novedades:**

> IC HEMATOLOGÍA IC CIRUGÍA GENERAL IC NEUMOLOGÍA (INICIO DE FTR) IC UROLOGIA

## Cama 10B: REYES SANCHEZ INES MAGDALENA C

- **HC:** `8140` | **Cédula:** 1703334647 | **Edad:** 79 AÑOS | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** HIPERTENSIÓN ARTERIAL; DIABETES MELLITUS 2; HIPOTIROIDISMO; HIPOACUSIA BILATERAL; GONARTROSIS BILATERAL; LINFOMA (GANGLIO LINFATICO NEGATIVO PARA MALIGNIDAD (0/1) FAMILIAR MENCIONA; QUE RECIBIO QUIMIO Y RADIOTERAPIA POR DICHO DIAGNOSTICO

**Diagnósticos Activos:**

- CHOQUE SÉPTICO DE FOCO PULMONAR SUPEREDO
- TROMBOSIS VENOSO MI DERECHO
- FLUTTER AURICULAR DE CONDUCCIÓN VARIABLE
- CAHVAS 5 , HAS BLED 3
- PO 250.5, SAFI 233

**Medicación Activa:**

- CEFEPIME 2 GRAMOS IV CADA 8 HORAS (0/7) FI: 13 NOV 2026 J189 (48 HORAS
- CLINDAMICINA 600 MG IV CADA CADA 8 HORAS (D:0) FI: 13 NOV 2026 J189
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA 12 HORAS
- PARACETAMOL 1 GRAMOS IV CADA 8 HORAS

- OMEPRAZOL 40 MG IV HS
- BISOPROLOL 5 MG VO BID
- ATORVASTATINA 40 MG VO HS
- LEVOTIROXINA 50 MCG VIA ORAL LUNES A JUEVES
- LEVOTIROXINA 75 MCG VO VIERNES SABADO Y DOMINGO
- INSULINA CRISTALINA POR ESCAPES:

**Pendientes:**

- ☐ URGENTE **[LABORATORIO]** E: RMN DE ENCEFALO AGENDAR HOY EN LA MAÑANA
- ☐ STAT **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** EKG CADA DIA (STAT)
- ☐ URGENTE **[LABORATORIO]** L: HOY BH UREA CREATININA ELECTROITOS CALCIO IONICO MAGNESIO DIMERO D
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** PCR PERFIL HEPATICO
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** GSA PRN
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** LABORATORIOS (17H02): ELEVACION AGUDA DE AZOADOS CON CR 1.99 (PREVIA 0.84) Y
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** UREA 185 (BUN 86). ELECTROLITOS CONSERVADOS (K 4.36, NA 141.9, MG 2.14, CA
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** IONICO 1.32). PERFIL INFECCIOSO EN DESCENSO (LEUCOCITOS 7.17, PCR 21.7). INR
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** 1.74

**Últimos Laboratorios:**

- *2026-11-14 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: CARDIO BISOPROLOL 5 BID ATB REINICIO, TAC CON PROCESO INFECCIOSO.

**Observaciones / Novedades:**

> IC NEUROLOGÍA IC CARDIOLOGÍA IC TRABAJO SOCIAL

## **Cama 10C**: BENAVIDES ANA LUCIA C

- **HC:** `639501` | **Cédula:** 1000997724 | **Edad:** 70 años | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** FRACTURA DE COSTILLAS DE LADO IZQUIERDO; INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA; ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA; HIPERTENSIÓN PORTAL; FIBROMIALGIA; HIPOTIROIDISMO; GOTA; ISQUEMIA MESENTÉRICA SEGMENTARIA

**Diagnósticos Activos:**

- DERRAME PLEURAL TABICADO IZQUIERDO
- NEUMONÍA ASOCIADA A CUIDADOS DE LA SALUD
- DESCARTAR PROGRESIÓN DE PATOLOGIA ONCOLOGICA (CANCER DE MAMA/CERVIX)

- PORTADORA DE YEYUNOSTOMÍA

**Medicación Activa:**

- SOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000 ML PASAR 40 ML/HORA
- MEROPENEM 1G IV CADA 8 HORAS (FI: 11/11/2026 D3 B99)
- PARACETAMOL 1 GR IV CADA 8 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIA

**Pendientes:**

- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** LABORATORIO CENTRAL 13/11/2026: BIOMETRÍA, LDH, PCR, ELECTROLITOS, MAGNESIO, CALCIO IÓNICO, PROTEÍNAS TOTALES, ALBÚMINA

## **Cama 10D**: OÑA TELLO JOSELYN CAROLINA

- **HC:** `1719421` | **Cédula:** N/R | **Edad:** 30 AÑOS | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES; SINDROME DE GARDNER; ARTRITIS REUMATOIDE, POLIARTRITIS CCP POSITIVO (DG A LOS 22 AÑOS); POLIPOMATOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR HACE 14 AÑOS; FISTULA ANAL; OBSTRUCCIÓN INTESTINAL PARCIAL; ANEMIA CRÓNICA; TRASTORNO ELECTROLÍTICO CRÓNICO

**Diagnósticos Activos:**

- INFECCIÓN O ABSCESO DE PARTES BLANDAS
- INFECCIÓN VÍAS URINARIAS TUMBARELLO 5 PUNTOS EN RESOLUCIÓN
- DOLOR CRÓNICO EXACERBADO
- PROCTORRAGIA OAKLAND DE 20 PUNTOS
- PROLONGACIÓN DE
- TIEMPOS DE COAGULACIÓN **SUSPERADA**
- ENFERMEDAD RENAL AGUDA SUPERADA *** SUPERADA**
- REACCION AL ESTRES GRAVE Y TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN

**Medicación Activa:**

- MEROPENEM 500 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS FI:13/11/2026 (DIA 0/5) (CIE10: A419)
- AMIKACINA 1 GRAMO VÍA ORAL FI: 11/11/2026 D: 02/2 ***SUSPENDER***
- FLUCONAZOL 400 MG IV CADA DIA FI: 11/11/2026 D: 03/7
- OMEPRAZOL 40 MG IV CADA DIA
- PARACETAMOL 1 GR IV CADA 8 HORAS
- FITOMENADIONA 10 MG IV CADA DIA
- MORFINA 35 MG + 96 CC DE SOLUCION SALINA 0.9% INTRAVENOSO, PASAR A 4CC/HORA
- MORFINA 3.5 MG INTRAVENOSO EN ESTE MOMENTO Y CASO DE DOLOR SEVERO, MAXIMO 3

- RESCATES, REGISTRAR EN SISTEMA PARA AJUSTE DE DOSIS BASAL
- ONDANSETRON 8 MG INTRAVENOSO EN ESTE MOMENTO Y CADA 12 HORAS

**Pendientes:**

- ☐ URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** PENDIENTE INFORME ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS DE CABEZ Y TORAX POSTERIOR
- ☐ URGENTE **[LABORATORIO]** PENDIENTE TOMOGRAFIA SIMPLE DE CABEZA, TORAX Y PELVIS
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** L: LABORATORIO CENTRAL 13/11/2026: BIOMETRIA, PCR, ELECTROLITOS,
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** UREA,CREATININA
- ☐ URGENTE **[INTERCONSULTA]** VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO POR EL COMITÉ DE BIOÉTICA

**Últimos Laboratorios:**

- *2026-11-14 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: UROCULTIVO: MICROORGANISMO: Proteus mirabilis AMIKACINA SENSIBLE / 4 ug/mL CEFTRIAXONA SENSIBLE / <= 0,25 ug/mL Cefazolina (O) SENSIBLE / <= 4 ug/mL GENTAMICINA RESISTENTE / 8 ug/mL TRIMETOPRIMA/SULFA RESISTENTE / >= 320 ug/mL CIPROFLOXACINO RESISTENTE / >= 4 ug/mL Resultado: Positivo; Contaje de Colonias: > 100.000 UFC/ml;

**Observaciones / Novedades:**

> C: INDICACIONES DE CLINICA DEL DOLOR INDICACIONES DE COLOPROCTOLOGIA INDICACIONES DE PSIQUIATRIA INDICACIONES DE PSICOLOGIA ORDENES DE CIRUGIA PLASTICA O. VALORACION Y SEGUIMIENTO POR EL COMITE DE BIOETICA

## **Cama 11A**: YELA DÍAS NELSON ARNULFO

- **HC:** `641333` | **Cédula:** 1705250726 | **Edad:** 78 años | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES:; ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 5 SECUNDARIA A NEFROPATÍA DIABÉTICA EN HEMODIÁLISIS TRISEMANAL (MARTES, JUEVES Y SÁBADO) NO OLIGÚRICO; INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS NOSOCOMIAL POR KLEBSIELLA PNEUMONIAE KPC/ENTEROCOCCUS FAECALIS SUPERADA; DIABETES MELLITUS TIPO 2; DISLIPIDEMIA; HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA; TAQUIARRITMIA CARDÍACA TIPO FIBRILACIÓN AURICULAR; HIPERPLASIA E HIPERTROFIA PROSTÁTICA BENIGNA

**Diagnósticos Activos:**

- DIAGNÓSTICOS ACTIVOS:
- NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN RESOLUCIÓN (CIE-10: J18.9)

- ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 5 EN HEMODIÁLISIS (CKD-EPI: 13.14 ML/MIN) (CIE-10: N18.5)
- DIABETES MELLITUS TIPO 2 (CIE-10: E11.9)
- HIPERTENSIÓN ARTERIAL (CIE-10: I10)

**Medicación Activa:**

- A PASAR 40ML/HORA
- CEFTRIAXOONE 2 GRAMOS IV CADA DIA (3/5) FI: 12/11/2026 A419
- HEPARINA SODICA 5000UI SC CADA 12 HORAS
- LOSARTAN 100 MG VO CADA DIA
- AMLODIPINA 10 MG VO CADA DIA
- CARVEDILOL 6.25 MG VO CADA DIA
- INSULINA NPH 32 UI SC AM
- INSULINA NPH 14 UI SC PM
- 180-230 2UI
- 231-280 3UI

**Pendientes:**

- [ ] URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** E: PD INFORME DE TAC DE TORAX
- [ ] STAT **[LABORATORIO]** GSA STAT
- [ ] URGENTE **[LABORATORIO]** L: HOY BH UREA CREATININA ELECTROLITOS PCR PERFIL LIPIDICO HBA1C TSH
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** CALCIO IONICO
- [ ] URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** LABORATORIOS (17H00): DESTACA MEJORIA DE AZOADOS POST-DIÁLISIS (UREA 67.8, CR
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** 3.90). SODIO EN 134.0. PERSISTEN LEUCOCITOSIS (14.03) Y ANEMIA (HB 9.0)

**Observaciones / Novedades:**

> C: IC CENTRO DE HEMODIALISIS IC NEUMOLOGIA (INICIO DE FTR)

## Cama 11B: PACHACAMA SUNTAXI FREDDY RODRIGO C

- **HC:** `20` | **Cédula:** 1713637401 | **Edad:** N/D | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO DIAGNOSTICO EN EL 2022; ANEMIA MODERADA MICROCITICA HIPOCROMICA; TROMBOEMBOLIA PULMONAR, ANGIO TOMOGRAFIA TORAX 12/09/2026; SEPSIS POR BACTERIEMIA POR SALMONELLA SUPERADO 10/2026; NEFRITIS LUPICA (POR CLINICA PROBABLE CLASE IV, SLEDAI 2K: 24 ACTIVIDAD; SEVERA); PROTEINURIA SUB NEFROTICA

**Diagnósticos Activos:**

- LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SLEDAI 2K 10 PUNTOS ACTIVIDAD ALTA
- NEFRITIS LÚPICA
- DERRAME PLEURAL LOCULADO
- ANEMIA MODERADA MICROCÍTICA HIPOCRÓMICA

**Medicación Activa:**

- CEFTRIAXONA A 2 G IV QD FI: 16/10/2026 D: 27 CIE 10 B99
- PARACETAMOL 1 GR IV CADA 8 HORAS
- MORFINA 4 MG IV EN LA TARDE, DESPUES DE ALMUERZO
- ENOXAPARINA 60 MG SC CADA 12 HORAS
- OMEPRAZOL 40 MG INTRAVENOSO CADA DIA
- CARBONATO DE CALCIO SOLIDO ORAL 500 MG VO QD 11 AM
- COTRIMOXAZOL SOLIDO ORAL 800/160 MG LOS DIAS MARTES JUEVES SABADO A LAS 2
- GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300 MG VO QD A LAS 9 PM
- TRAMADOL 100 MG INTRAVENOSO CADA 8 HORAS
- METOCLOPRAMIDA 10 MG INTRAVENOSO CADA 8 HORAS

**Pendientes:**

- ☐ RUTINA **[INTERCONSULTA]** INDICACIONES DE REUMATOLOGÍA
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** L: BIOMETRIA, ELECTROLITOS, FUNCION RENAL 12/11/2026
- ☐ RUTINA **[INTERCONSULTA]** BRONCOSCOPIA:10-11-2026
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** INFILTRACION GRADO II DE CARINA SECUNDARIA ENTRE LOBULO SUPERIOR E INFERIOR
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** IZQUIERDO
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** TRAQUEOBRONQUITIS LEVE NO PURULENTA

**Últimos Laboratorios:**

- *2026-11-14 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: CULTIVO DE LIQ. PLEURAL: MICROORGANISMO: SALMONELLA ENTERICA SSP ENTÉRICA . SENSIBLE A CEFTRIAXONA . LABORATORIOS RECIENTES: HB EN DESCENSO (10.7 G/DL), LEUCOCITOS NORMALES (8.67), FUNCION RENAL CONSERVADA (CR 0.58), ELECTROLITOS EN RANGO (K 3.5). PCR EN DESCENSO CLARO (17.00 PREVIA).

**Observaciones / Novedades:**

> INMUNOLÓGICOS LABORATORIO ZURITA Y ZURITA 23-09-2026 ANTICUERPOS ANTI-PEPTIDO CITRULINADO (ANTICCP): INFERIOR A 0,50 U/ML-NEGATIVO ANTICUERPOS ANTI-SM (SMITH): INFERIOR A 3,3 CU - NEGATIVO ANTICUERPOS ANTI-CARDIOLIPINA IGM: 2,10 CU - NEGATIVO ANTICUERPOS ANTI-CARDIOLIPINA IGG: 9,50 CU - NEGATIVO ANTICUERPOS ANTI-BETA2 GLICOPROTEINA 1 IGM: INFERIOR A 1,1 CU - NEGATIVO

## **Cama 12A**: NICOLALDE CENTENO CESAR ENRIQUE

- **HC:** `554153` | **Cédula:** 1715905293 | **Edad:** 40 AÑOS | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** SINDROME . DE DOWN; HIPOTIROIDISMO; POLIGLOBULIA; DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL 70%

**Diagnósticos Activos:**

- HEPATOPATÍA EN ESTUDIO EN ESTUDIO DE POSIBLE HEPATITIS TÓXICA VS MEDICAMENTOSAS
- NEUTEOFEMIA CON ANTIBIOTICO TERAPI EMPÍRICA
- BICITOPENIA EN ESTUDIO
- TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO LEVE
- HIPOGLICEMIA REFRACTARIA SUPERADA
- DC. PARANEOPLÁSICO
- INFECCION DE VIAS URINARIAS
- SINDROME HEPÁTICO MIXTO COLESTÁSICO Y CITOLITICO

**Medicación Activa:**

- CEFEPIME 2 GRAMOS IV CADA 8 HORAS (2/3) FI:10/11/2026
- ACICLOVIR 400MG VO CADA 12 HORAS (1/5)
- FLUCONAZOL 400MG VO CADA DIA (1/5)
- LEVOTIROXINA 75MCG VO CADA DIA
- TRAMADOL 50MG + 50ML SS 0.9% IV PASAR PRN
- RISPERIDONA 8 GOTAS VO PRN (AGITACION PSICOMOTRIZ)
- QUETIAPINA 25 MG VO HS , ADICIONAR 25 MG VO HS PRN

**Pendientes:**

- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** PD RESULTADOS DE BIOPSIA
- [ ] URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** PD REALIZACION ECO DOPPLER PORTAL
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** 11.11.2026
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** MEDULOGRAMA: DILUIDO, NO VALORABLE
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** IMPRONTA: DILUIDO NO VALORABLE
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** 10.11.2026 FROTIS DE SANGRE PERIFERICA
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** FORMULA DIFERENCIAL MANUAL
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** SEGMENTADOS: 68 %
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** LINFOCITOS: 16 %
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** MONOCITOS:16 %
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** HIPOSEGMENTADOS +++

**Últimos Laboratorios:**

- *2026-11-14 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: 22026/11/12 PCR CUANTITATIVO ULTRASENSIBLE: 78.40 Leucocitos (WBC): 2.11 Hemoglobina (HGB): 11.8 Hematocrito (HCT):

35.4 Volumen corp. medio (MCV): 95.60 Conc. media hemog. (MCH): 31.8 Neutrofilos: 1.68 Basófilos: 0.000 Plaquetas: 55.000 CLORO: 100 POTASIO: 3.46 SODIO: 136.7 NITROGENO UREICO EN SUERO: 17 UREA SUERO: 37.1 CREATININA: 0.44

**Observaciones / Novedades:**

> L: PD RESULTADOS DE LAB CENTRAL C: ORDENES DE HEMATOLOGIA ORDENES DE PSIQUIATRIA O: NOVEDADES

## **Cama 13B**: CANTOS AGUIRRE GUADALUPE ESPERANZA C

- **HC:** `140019` | **Cédula:** 1703701944 | **Edad:** 73 AÑOS | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES; HIPERTENSION ESENCIAL DX A LOS 40 AÑOS; INFECCION DE VIAS URINAS RECURRENTES; TRASTONO DE ANSIEDAD- INSOMNIO

**Diagnósticos Activos:**

- DIAGNÓSTICOS ACTIVOS:
- CRISIS CONVULSIVA EN ESTUDIO
- INFECCION DE VIAS URINARIAS K. PNEUMONIAE SENSIBLE
- HIPONATREMIA SUPERADA
- HIPOKALEMIA MODERADA

**Medicación Activa:**

- CEFTRIAXONA 2 GR INTRAVENOSO CADA DIA D5/7 FI 09/11/2026, CIE-10:
- PARACETAMOL 1 GRAMO INTRAVENOSO POR RAZONES NECESARIAS
- OMEPRAZOL 20 MG VIA ORAL CADA DIA
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIA
- ACIDO VALPROICO 500 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS
- LOSARTAN 100 MG VIA ORAL CADA DIA AM
- AMLODIPINO 10 MG VIA ORAL CADA DIA PM
- CARVEDILOL 12.5 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS
- GABAPENTINA 300 MG VIA ORAL CADA DIA 18:00
- MIDAZOLAM 2.5 MG INTRAVENOSO PREVIO A SEDACION

**Pendientes:**

- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** E: RESONANCIA MAGNETICA SIMPLE Y CONTRASTADA DE ENCEFALO EL DIA DOMINGO CON SEDACION
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** ELECTROENCEFALOGRAMA
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** L: NO

**Observaciones / Novedades:**

> INDICACIONES DE NEUROLOGIA

## Cama 6A: RODRIGUEZ MORENO SEGUNDO EZEQUIEL

- **HC:** `2013397` | **Cédula:** 1709777906 | **Edad:** 59 AÑO | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** HIPOTIROIDISMO; HIPERTENSIÓN ARTERIAL; NEUMONIA ASOCIADA A LA COMUNIDAD FINALES DE OCTUBRE/2026, ENVIADO CON ANTIBIOTICOTERAPIA VIA ORAL + INHALADORES; HIPERTENSIÓN ARTERIAL; ARTRITIS REUMATOIDE EN SEGUIMIENTO POR REUMATOLOGÍA IESS DISPENSARIO; EN REVALORACIÓN AL MOMENTO; NEUMONIA HACE DOS AÑOS

**Diagnósticos Activos:**

- INSUFICIENCIA RESPIRATORIA
- NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD. CIE 10: J159 SUPERADA
- CHOQUE SÉPTICO DE FOCO PULMONAR SUPERADO CIE 10: R572
- LESIÓN RENAL AGUDA KDIGO C3 CIE-10: N179 SUPERADO

**Medicación Activa:**

- PARACETAMOL 1 GRAMO VÍA ORAL CADA 8 HORAS
- OMEPRAZOL 40 MILIGRAMOS INTRAVENOSO CADA DIA
- ENOXAPARINA 60 MG APLICAR SUBCUTANEO, CADA DIA
- LEVOTIROXINA 50 MICROGRAMO VIA ORAL CADA DIA 06:00
- TRAMADOL 50 MILIGRAMOS INTRAVENOSO POR RAZONES NECESARIAS
- METOCLOPRAMIDA 10 MILIGRAMOS INTRAVENOSO POR RAZONES NECESARIAS
- HIDROCORTISONA 150 MG IV QD 8 AM
- TRI-K 10 ML DILUIR EN MEDIO VASO DE JUGO DE NARANJA VO CADA 8 HORAS (D3/3)
- ENALAPRIL 10 MILIGRAMO VIA ORAL CADA DIA
- PREDNISONA 20 MILIGRAMO CADA DIA ***SUSPENDE HACE 3 DIAS***

**Pendientes:**

- [ ] URGENTE **[LABORATORIO]** PENDIENTE EXÁMENES GENERADOS EL 12/11/2026
- [ ] RUTINA **[INTERCONSULTA]** INDICACIONES DE REUMATOLOGÍA
- [ ] URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** PENDIENTE TAC SIMPLE DE TÓRAX
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** C: COMUNICAR
- [ ] URGENTE **[INTERCONSULTA]** VALORACIÓN POR NEUMOLOGÍA
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** INICIO DE OXIGENO DOMICILIARIO
- [ ] RUTINA **[INTERCONSULTA]** REUMATOLOGÍA
- [ ] RUTINA **[INTERCONSULTA]** INDICACIONES DE DERMATOLOGÍA

- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** UREA 10% SEMISÓLIDO CUTANEO APLICAR TOPICO BID POR 15 DIAS EN MANOS
- [ ] CONTROL **[LABORATORIO]** PROXIMO CONTROL: 06/11/2026

**Últimos Laboratorios:**

- *2026-11-14 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: 10/11/2026 ÁCIDO LÁCTICO.: 1.0 BE.: 5.5 Ca: 1.1 Cl: 100.0 COHb: 1.9 Glu: 130.0 HCO3: 28.8 Hct: 33.7 K.: 3.9 MetHb.: 0.2 Na.: 137.0 O2Hb: 61.8 O2SAT.: 63.1 PCO2.: 37.6 PHS: 7.493 PO2: 32.6 TCO2.: 30.0 Leucocitos (WBC)..: 4.98 Hemoglobina (HGB): 10.6 Hematocrito (HCT).: 33.0 Volumen corp. medio (MCV).: 85.40 Conc.media hemog.(MCH).....: 27.4 Con

**Observaciones / Novedades:**

> LABORATORIOS SOLICITADOS POR REUMATOLOGÍA: FACTOR REUMATOIDEO 13.1 C3 0.85 C4 0.07 ANTICOAGULANTE LUPICO 1.08 EXAMENES DE LABORATORIO POR SERVICIO BASE: FACTOR REUMATOIDE, ANTICOAGULANTE

## Cama 6C: ALMEIDA JARAMILLO JUAN CARLOS C

- **HC:** `2086486` | **Cédula:** 1705956132 | **Edad:** 65 años | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES:; HIPERTENSIÓN ARTERIAL DIAGNOSTICADA EN EL 2004; DIABETES MELLITUS DIAGNOSTICADA EN EL 2014; CEFALEA DESDE EL 2020; DOLOR EN MIEMBRO SUPERIOR DERECHO DESDE HACE 3 MESES

**Diagnósticos Activos:**

- ADENOPATÍAS GENERALIZADAS (CERVICALES, AXILARES, INGUINALES)
- HIPERTENSIÓN ARTERIAL
- DIABETES MELLITUS
- SINDROME CONSTITUCIONAL

**Medicación Activa:**

- AMLODIPINO 5 MG VO QD PM
- METFORMINA 850 MG VO TID * SUSPENDER *
- AMITRIPTILINA 25 MG VO QD PM
- TRAMADOL 10 GOTAS VO BID
- IBUPROFENO 400 MG VO QD X 15 DIAS
- PARACETAMOL 1 GR VIA ORAL CADA 8 HORAS
- INSULINA NPH 12 UI SC AM Y 6 I SC PM

**Pendientes:**

- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** E: EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS:
- [ ] URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** TAC SIMPLE DE CRÁNEO PENDIENTE
- [ ] URGENTE **[LABORATORIO]** PENDIENTE REALIZACIÓN
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** RMN SIMPLE DE COLUMNA CERVICAL MADRUGADA DEL 13 DE NOVIEMBRE
- [ ] URGENTE **[LABORATORIO]** PAAF DE GANGLIO CERVICAL (IMAGEN) PENDIENTE REALIZACIÓN
- [ ] RUTINA **[INTERCONSULTA]** INDICACIONES DE CIRUGÍA ONCOLÓGICA
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** 2026/11/11 12:04 ENDOSCOPIA
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** DIAGNÓSTICO
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** LESION DE ASPECTO PAPILOMATOSO EN ESOFAGO MEDIO RESECADO
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** GASTROPATIA ERITEMATOSA LEVE DE ANTRO
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** CICATRIZ LINEAL DE ULCERA PREVIA EN CUERPO SAKITA MIWA H2
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** ESTUDIO NEGATIVO PARA LESIONES NEOPLASICAS

**Últimos Laboratorios:**

- *2026-11-14 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: 2026/11/09 TSH.: 1.30 INR.: 1.14 TIEMPO DE PROTROMBINA (TP).: 12.4 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (TTP)..: 28.3 Leucocitos (WBC).: 5.67 Hemoglobina (HGB).: 16.0 Hematocrito (HCT).: 47.9 Eosinófilos %.: 2.7 Linfocitos %.: 36.6 Neutrofilos %.: 54.1 COLESTEROL HDL: 32.10 COLESTEROL LDL: 104.70 GLUCOSA.: 98 CLORO: 106 POTASIO: 3.84 SODIO: 138.2 CALCIO IONICO

## Cama 6D: FARINANGO ANDRADE JUAN MANUEL

- **HC:** `N/D` | **Cédula:** N/R | **Edad:** 88 AÑOS | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** HIPOTIROIDISMO; DIABETES TIPO 2; HIPERPLASIA PROSTÁTICA; COLECISTECTOMIA; CATARATA BILATERAL; LIPOMA EN BRAZO DERECHO

**Diagnósticos Activos:**

- DERRAME PLEURAL GRADO 2
- SINDROME CONSTITUCIONAL
- COLECCIÓN SUBFRÉNICA EN ESTUDIO

**Medicación Activa:**

- PARACETAMOL 1 GR IV CADA 8 HORAS
- METOCLOPRAMIDA 10 MG IV PRN
- FUROSEMIDA 40 MG IV 08H00 AM Y 20 MG IV 14H00
- CEFTRIAXONA 1 GR IV CADA 12 HORAS (D:4) FI:10/11/2026 CIE10: A065
- METRONIDAZOL 500 MG IV CADA 8 HORAS (D:4) FI:10/11/2026 CIE10: A065

- LOSARTAN 50 MG VO QD
- LEVOTIROXINA 75 MCG VO QD
- TAMSULOSINA 0,4 MG VO QD
- METFORMINA 500 MG VO QD *******SUSPENDIDO.******

**Pendientes:**

- ☐ URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** E: PENDIENTE RX DE TÓRAX ANTEROPOSTERIOR Y LATERAL
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** CIRUGÍA PULMONAR ALTA

**Últimos Laboratorios:**

- *2026-11-14 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: 2026/11/12 PCR CUANTITATIVO ULTRASENSIBLE: 75.80 PROCALCITONINA LAB. CLÍNICO: 0.19 INR: 1.23 TIEMPO DE PROTROMBINA (TP): 13.3 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (TTP): 25.5 LEUCOCITOS (WBC): 4.65 HEMOGLOBINA (HGB): 13.7 HEMATOCRITO (HCT): 44.2 VOLUMEN CORP. MEDIO (MCV): 85.60 CONC. MEDIA HEMOG. (MCH): 26.6 LINFOCITOS: 0.78 NEUTROFILOS: 3.33 BASÓFILOS: 0.040

## **Cama 6 B**: CABEZAS ALMEIDA VICTOR MANUEL

- **HC:** `2067347` | **Cédula:** N/R | **Edad:** 78 años | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES:; HIPERTENSION ARTERIAL; CA PROSTATA; INSUFICIENCIA RENAL DIALISIS BISEMANAL; ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS:; APENDICECTOMÍA

**Diagnósticos Activos:**

- DIAGNÓSTICOS ACTIVOS:
- CELULITIS DE OTROS SITIOS (L038)
- ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (N185)
- ÚLCERA DE DECÚBITO Y POR ÁREA DE PRESIÓN L899
- TROMBOCITOPENIA SEVERA
- DIAGNÓSTICOS PASIVOS:
- HIPERTENSIÓN ARTERIAL
- CA PRÓSTATA

**Medicación Activa:**

- MEROPENEM 1 GRAMO QD Y 1 GRAMO POSTERIOR A CADA DIÁLISIS FI: 11/11/2026
- AMLODIPINO 10 MG VÍA ORAL CADA

**Pendientes:**

- ☐ URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** PLACA ED PELVIS PENDIENTE REVISAR

- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** EXAMENES LUEGO DE DIÁLISIS: BH, PCR, PROCALCITONINA

**Observaciones / Novedades:**

> LABORATORIOS 2026/11/11 13:44 CÁLCULO DE PLAQUETAS 130.000 Leucocitos (WBC 5.81 Hemoglobina (HGB 10.8 Hematocrito (HCT 33.4

## **Cama 7**: VINUEZA ROJAS ARTURO MIGUEL 77 AÑOS 239902

- **HC:** `N/D` | **Cédula:** N/R | **Edad:** 77 años | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** ANTECEDENTES PERSONALES:; HIPERTENSION ARTERIAL DIAGNOSTICADO HACE 30 AÑOS; DISLIPIDEMIA; ENFERMEDAD RENAL CRONICA; ANTECEDENTES QUIRURGICOS:; APENDICECTOMIA; RECONSTRUCCION NASAL; CRANEOTOMIA FRONTO TEMPORO PARIETAL IZQUIERDA MAS EVACUACION DE

**Diagnósticos Activos:**

- TRAQUEITIS
- HIPERTENSIÓN ARTERIAL
- DISLIPIDEMIA
- ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 3B (TFG POR CKD-EPI: 31,84)
- PORTADOR DE TRAQUEOSTOMO
- HEMATOMA SUBDURAL AGUDO HEMISFERICO IZQUIERDO PARIETAL DERECHO EVACUADO
- NECROSIS DE COLGAJO EN CUERO CABELLUDO RESUELTO PARIETAL POSTERIOR IZQUIERDO +
- INFECCION DE HERIDA QUIRURGICA FRONTO TEMPORO PARIETAL IZQUIERDA + EMPIEMA

**Medicación Activa:**

- LEVETIRACETAM 500 MILIGRAMOS POR GASTROSTOMIA CADA 12 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC QD
- BUSCAPINA 1 TABLETA POR GASTROSTOMIA C/8H
- EMPAGLIFLOZINA 10 MILIGRAMOS POR SONDA OROGASTRICA CADA DIA
- SIMVASTATINA 40 MILIGRAMOS POR SONDA OROGASTRICA CADA DIA
- NEBULIZACIONES CON BROMURO DE IPRATROPIO 2 ML + SOLUCION SALINA 0.9% 5 ML
- CADA 6 HORAS
- LAGRIMAS ARTIFICIALES UNA GOTA CADA 2 HORAS AMBOS OJOS SIEMPRE

**Observaciones / Novedades:**

> O: FTR RESPIRATORIA Y REHABILITACIÓN CURACIONES AVANZADAS POR CLÍNICA DE

> HERIDAS

## Cama 8: ENCARGO INFECTOLOGIA.

- **HC:** `N/D` | **Cédula:** N/R | **Edad:** N/D | **Sexo:** N/R

**Diagnósticos Activos:**

## Cama 9A: CHANCUSI COSTALES MONICA ELIZABETH C

- **HC:** `347767` | **Cédula:** 1708946098 | **Edad:** 59 años | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** ANTECEDENTES PERSONALES:; ANSIEDAD Y DEPRESIÓN DIAGNOSTICADA HACE 8 AÑOS; ANTECEDENTES QUIRURGICOS:; APENDICECTOMÍA; CESAREA X 3; OOFORECTOMÍA; HISTERECTOMIA ,; ALERGIAS A MEDICAMENTOS: PENICILINA

**Diagnósticos Activos:**

- EFECTO TOXICO ENVENENAMIENTO POR ANTIDEPRESIVO TRICICLICO CIE-10: T430 SUPERADO
- TRASTORNO ANSIOSO DEPRESIVO CIE-10: F412

**Medicación Activa:**

- ENOXAPARINA 40 MILIGRAMOS APLICAR SUBCUTANEO, CADA DIA
- OMEPRAZOL 40 MILIGRAMOS INTRAVENOSO CADA DIA
- PARACETAMOL 1 GRAMO INTRAVENOSO POR RAZONES NECESARIAS
- SULFATO DE MAGNESIO 2 GRAMOS INTRAVENOSO CADA DIA
- METOCLOPRAMIDA 10 MILIGRAMOS IV CADA 8 HORAS
- **********INDICACIONES PSIQUIATRIA 13/11/26**********
- RISPERIDONA 1 MG VO HS

**Pendientes:**

- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** SEGUIMIENTO POR PSIQUIATRIA
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** INDICACIONES DE PSIQUATRIA

## Cama 9B: CARRERA AGUIRRE MARTHA GRACIELA C

- **HC:** `2045964` | **Cédula:** 1702915719 | **Edad:** 88 años | **Sexo:** N/R

- **Antecedentes (APP):** DEMENCIA NO ESPECIFICADA DIAGNOSTICADA POR GERIATRIA; HIPERTENSIÓN ARTERIAL; PÉNFIGO VULGAR; INFECCION DE VIAS URINARIAS (HOSPITALIZADA SEPTIEMBRE 2025); TRASTORNO BIPOLAR DIAGNOSTICADO 2023

**Diagnósticos Activos:**

- TRASTORNO DEGLUTORIO EN CONTEXTO DE DEMENCIA TIPO ALZHEIMER
- ANEMIA MODERADA MACROCÍTICA
- ZONA DE PRESIÓN EN SACRO ANTERIOR EN CICATRIZACIÓN
- NEUMONIA POR ASPIRACION SUPERADA
- HIPERNATREMIA SEVERA HIPOVOLEMICA AGUDA SINTOMATICA SUPERADA
- LESIÓN RENAL AGUDA KDIGO C2 SUPERADA

**Medicación Activa:**

- PARACETAMOL 1 G IV PRN
- ENOXAPARINA 40 MG SC QD
- FUROSEMIDA 40 MG INTRAVENOSO CADA DIA
- ESPIRONOLACTONA 25 MG POR SONDA NASOGÁSTRICA
- ***SUSPENDER*** AMPICILINA + SULBACTAM 3 G IV CADA 6 HORAS FI: 29/10/2026 CIE
- DE GASTROSTOMIA DEXTROSA EN AGUA AL 10%, 50 ML CADA 6 HORAS
- DILUIDA
- CURACION DE AREA DE OSTOMIA CADA DIA CON SOLUCION SALINA Y POR
- ROTACION HORARIA - ANTI HORARIA DE SONDA QD
- MEDIR RESIDUO GASTRICO ANTES DE SIGUIENTE ALIMENTACION

**Pendientes:**

- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** E. NO AMERITA
- ☐ URGENTE **[LABORATORIO]** L. PENDIENTE RESULTADOS DE ELECTROLITOS 12/11/2026
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** C. INDICACIONES DE GASTROENTEROLOGIA: GASTROSTOMIA 12/11/2026 16:00

**Últimos Laboratorios:**

- *2026-11-14 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: 2026/11/13 CLORO….: 95 POTASIO…: 3.73 SODIO..: 129.2 CALCIO IONICO EN SUERO..: 1.16 CALCIO IONICO EN SUERO..: 1.16 CALCIO TOTAL: 7.3 FOSFORO..: 3.5 MAGNESIO: 1.63 . 2026/11/11 CLORO….: 93 POTASIO…: 4.68 SODIO: 127.8

## Cama 9C: MORENO BARRIGA BLANCA ALICIA

- **HC:** `1734898` | **Cédula:** 0500728902 | **Edad:** 72 AÑOS | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO DE MÚLTIPLES TERRITORIOS Y BILATERALES; INSUFICIENCIA CARDIACA FEVI PRESERVADA 60% PERFIL

HEMODINÁMICO A, ETIOLOGIA VALVULAR POR ESTENOSIS AÓRTICA SEVERA, ESTADIO C, NYHA II; SINDROME NEFRÓTICO EN ESTUDIO; INJURIA MIOCÁRDICA AGUDA SECUNDARIA A SINDROME CEREBRO CORAZON, TIPO II; DISLIPIDEMIA DIAGNOSTICADA HACE APROXIMADAMENTE 2 MESES, SIN TRATAMIENTO

**Diagnósticos Activos:**

- SINDROME NEFRÓTICO
- INSUFICIENCIA CARDIACA FEVI PRESERVADA 60% PERFIL HEMODINÁMICO A, ETIOLOGIA VALVULAR POR ESTENOSIS AÓRTICA SEVERA, ESTADIO C, NYHA II DESCOMPENSADA
- HIPOKALEMIA LEVE EN REPOSICIÓN
- BACTERIURIA ASINTOMATICA

**Medicación Activa:**

- OMPERAZOL 20 MG P.O QD
- UROCIT 2 CAPSULAS VIA ORAL CADA 8 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SUBCUTANEO CADA 12 HORAS
- PARACETAMOL 1 GRAMO INTRAVENOSO POR RAZONES NECESARIAS
- ATORVASTATINA 40 MG VO QD ( ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR
- BETAHISTINA 48 MG VO QD
- EMPAGLIFLOZINA 25 MG VIA ORAL CADA DIA
- ENALAPRIL 5 MG VO QD
- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 12 HORAS
- POLIETILENGLICOL 1 CUCHARADA VIA ORAL CADA 12 HORAS

**Pendientes:**

- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** PD RESULTADO RESULTADO DE ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** SE PROGRAMA CURETAJE PERIODONTAL DE PIEZA DENTAL 36 PARA EL DIA JUEVES 12
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** DE NOVIEMBRE DE 2026 A LAS 16H00
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** ODONTOLOGIA REALIZA PROCEDIMIENTO
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** INDICACIONES DE NEFROLOGIA

**Últimos Laboratorios:**

- *2026-11-14 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: CLORO: 114 POTASIO: 3.47 SODIO: 143.3 CALCIO IÓNICO EN SUERO: 1.19 CALCIO TOTAL: 7.4 FÓSFORO: 3.1 MAGNESIO: 1.96

**Observaciones / Novedades:**

> EKG CADA DIA PD INFORME DE BODY TAC SIMPLE Y CONTRASTADA ECO RENAL PD REALIZAR EDA Y COLONOSCOPIA EL DIA DOMINGO 15-11-2026 YA EN PREPARACION

## **Cama 9D**: GUERRERO PAULA DOLORES NARCIZA

- **HC:** `677814` | **Cédula:** N/R | **Edad:** 63 años | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONAES; EPILEPSIA. SECUNDARIA A TRAUMATISMO HACE 17 AÑOS; HIPOTIROIDISMO; DISLIPIDEMIA; LESIONES VASCULARES CEREBRALES EN IMAGEN; HIPONATREMIA CRONICA; TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA DE MIEMBRO INFERIOR DERECHA; RESIDENTE EN CENTRO DE CUIDADO, DEPENDIENTE DE TERCERAS PERSONAS

**Diagnósticos Activos:**

- DIAGNOSTICO:
- ANEMIA MACROCITICA SEVERA AGUDA (CAIDA DE HB A 8.1 G/DL - EN SOPORTE
- TRANSFUSIONAL)
- SEPSIS DE FOCO PULMONAR / NEUMONIA ASPIRATIVA (DIA 4 DE TRATAMIENTO)
- DESCARTE DE MENINGOENCEFALITIS VS. ENCEFALOPATIA TOXICO-METABOLICA
- EPILEPSIA SECUNDARIA A TRAUMA / DEMENCIA VASCULAR
- CONSTIPACION
- HIPERNATREMIA MODERADA Y TROMBOCITOPENIA (RESUELTAS)

**Medicación Activa:**

- IV PASAR 60ML/HORA
- PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4.5 GRAMOS IV CADA 6 HORAS (4/5) FI:09/11/2026 A419
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIA
- PARACETAMOL 1 GRAMO IV PRN
- BROMURO DE IPATROPIO 2 PUFF CADA 8 HORAS
- ATORVASTATINA 40 MG VO CADA DIA
- ACIDO VALPROICO 1000MG VO CADA 12 HORAS
- LEVOTIROXINA 125 MG VO CADA DIA
- FUROSEMIDA 40MG IV DESPUES DE PAQUETE GLOBULAR

**Pendientes:**

- [ ] URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** PD RESULTADOS DE TAC DE TORAX
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** PD RESULTADOS HEMOCULTIVO

**Últimos Laboratorios:**

- *2026-11-14 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: 2026/11/12 HORA: 08:39 LEUCOCITOS (WBC): 5.72 HEMOGLOBINA (HGB): 8.1 HEMATOCRITO (HCT): 25.0 VOLUMEN CORP.

MEDIO (MCV): 100.60 CONC. MEDIA HEMOG. (MCH): 32.4 CONC. CORP. MEDIA (MCHC) DE HEMO: 32.4 VOLUMEN MEDIO PLAQUETARIO (MPV): 11.5 MONOCITOS: 0.45 EOSINOFILOS: 0.05 LINFOCITOS: 2.65 NEUTROFILOS: 2.51 BASOFILOS: 0.030 PLAQUETAS: 117.000 RECUENTO D

**Observaciones / Novedades:**

> MAÑANA 05H00 BH UREA CREATININA ELECTROLITOS

## Cama **HOSP_18**: ORTIZ MARIA ANGELA C

- **HC:** `520780` | **Cédula:** 1702106038 | **Edad:** 98 años | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** HIPERTENSION ARTERIAL; INSOMNIO; ARTROSIS

**Diagnósticos Activos:**

- SEPSIS DE FOCO URINARIO
- LESION RENAL AGUDA KDIGO II
- HIPOKALEMIA LEVE
- HIPONATREMIA LEVE HIPOVOLEMICA ISOSMOLAR AGUDA ASINTOMATICA

**Medicación Activa:**

- CLORURO DE SODIO AL 0.9% PASAR INTRAVENOSO A 40ML/H
- MEROPENEM 1G INTRAVENOSO STAT Y CADA 8 HORAS (FI: 13/11/2026 D0 N390) *
- PARACETAMOL 1 GRAMO INTRAVENOSO POR RAZONES NECESARIAS
- FUROSEMIDA 20 MG INTRAVENOSO CADA DIA
- QUETIAPINA 25 MG VIA ORAL HORA SUEÑO, POR 3
- BROMURO DE IPATROPIO 2 PUFFS CADA 8 HORAS
- ESCITALOPRAM 10 MG VIA ORAL CADA DIA AM, P
- HEPARINA SODICA 5000 UI SC CADA DIA
- OMEPRAZOL 40 MG INTRAVENOSO CADA DIA

**Pendientes:**

- [ ] CONTROL **[LABORATORIO]** LUNES EXAMENES DE LABORATORIO DE CONTROL
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** INDICACION DE INFECTOLOGIA
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** PD RESULATDO DE UROCULTIVO

**Últimos Laboratorios:**

- *2026-11-14 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: 13/11/2026 PCR: 280, PCT: 20.2 . LEU: 10.3, HG: 12, HCTO: 36, NEU: 8.7, PLAQ: 185.000. CLORO: 96, POTASIO: 3.3, SODIO: 132. . UREA: 90 CREA: 1.77 . EMO INFECCIOSO